

ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ರೋಗಿಯ ಹೆಸರು:	ವಯಸ್ಸು	ಲಿಂಗ:
ಯು ಹೆಚ್ ಐ ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಓ ಪಿ /ಐ ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ:	ದಿನಾಂಕ:
ರೋಗನಿರ್ಣಯ:		

ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (ತೀವ್ರ / ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ) ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರುಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇದು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವಿವರಗಳು: ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ (ಮಧ್ಯಂತರ), ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಸೋಸುವಿಕೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ (ಮೆಂಬರೇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್). ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ಎ ವಿ ಫಿಸ್ಟುಲಾ/ಗ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟೇಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎ ವಿ ಫಿಸ್ಟುಲಾ/ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಾಳೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪೋರ್ಟ್ (ಉದಾ. ಆಂತರಿಕ ಜುಗುಲಾರ್/ಸಬ್ಕ್ಲಾವಿಯನ್ ಸಿರೆ) ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ರಕ್ತವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೊರೆಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪೊರೆಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೋಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ನಿಂದ 'ಕೊಳಕು' ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ದ್ರವವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'ಶುದ್ಧ' ರಕ್ತವನ್ನು ಎರಡನೇ ಸೂಜಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅವಧಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಿ ಎ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕುಹರದೊಳಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮೆಂಬರೇನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು:

☐ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ (ಐ ಹೆಚ್ ಡಿ) ☐ ನಿರಂತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಬದಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ) ☐ ನಿಧಾನ ಕಡಿಮೆ ದಕ್ಷತೆಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ (ಎಸ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಡಿ) ☐ ನಿರಂತರ ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ (ಸಿ ಎ ಪಿ ಡಿ)

ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನುರಿತ ಅನುಭವಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ರೋಗಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ರೋಗಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ರಕ್ತದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, _____

ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳು:

- ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ (ಕಡಿಮೆ ಬಿಪಿ ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಬಿಪಿ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ) ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ರೋಗಿಯನ್ನು ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
- ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕುವ (ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವ) ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದ್ರವಗಳು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

- ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಲಯದ ಅನಿಯಮಿತತೆಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು . (ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ಜ್ವರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ). ಇದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
- ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಡಯಾಲಿಸರ್ ಮೆಂಬರೇನ್, ಐ ವಿ ದ್ರವ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಎದೆ ನೋವು (ಆಂಜಿನಾ), ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ (ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆ ಇರುವಿಕೆ) ಮುಂತಾದ ತೊಡಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು .ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
- ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಆಂತರಿಕ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ರಕ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕೆಗಾಗಿ (ಹೆಪಾರಿನ್ ನಂತಹ) ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು .
- ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು (ಹಿಮೋಲಿಸಿಸ್). ಇದು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ, ಎಚ್‌ಐವಿ ಮುಂತಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸಿಎಪಿಡಿ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕುಹರದ (ಪೆರಿಟೋನಿಟಿಸ್) ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. _____

ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರ್ಯಾಯಗಳು: ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ, ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ _____

ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ತೊಡಕಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾನು ಸಹ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ರೋಗಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅವಲಂಬಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಮ್ಮತಿ ನಮೂನೆಯ ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ) ಪ್ರತಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ (ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಂತ್ರಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಇಂಟರ್ ಡಯಾಲಿಟಿಕ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳು). ರೋಗಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ.

	ಹೆಸರು	ಸಹಿ	ದಿನಾಂಕ	ಸಮಯ
ರೋಗಿ				
ರೋಗಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ಸಂಬಂಧ ವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ)				
ರೋಗಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಸಹಿಹಾಕಲು ಕಾರಣ	ರೋಗಿಯು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ:			
ವೈದ್ಯರು				
ಸಾಕ್ಷಿ				
ಅನುವಾದಕಾರ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ)				